

20 - 08- Mélanomes - Pr. Amal

Bonjour, le cours d'aujourd'hui est intitulé « Les mélanomes ». Après ce cours, l'étudiant doit être capable d'identifier les facteurs prédisposants aux mélanomes. C'est très important sur le plan préventif. Diagnostiquer un mélanome, surtout au stade de début, parce que lorsqu'on découvre le mélanome in situ, au stade de début, le pronostic est bon, avec un temps de guérison aux alentours de 90%.

Citer les éléments pouvant faire craindre la dégénérescence d'un névus, ou la survenue d'un mélanome sur un névus. Distinguer les différentes formes cliniques de mélanomes et connaître les principes thérapeutiques du mélanome. Le mélanome est une tumeur maligne développée à partir des mélanocytes.

C'est une lésion redoutable à haut potentiel métastatique. Vous avez le carcinome baso-cellulaire qui est le cancer le plus gentil de tous les cancers de l'être humain, et vous avez le mélanome qui est le cancer le plus méchant. En Europe surtout, vous avez une fréquence en augmentation régulière.

En France par exemple, c'est un problème de santé publique dans les pays européens, en Australie, en France. Vous avez 4000 à 6000 nouveaux cas par an. Donc au Maroc ou en Marrakech par exemple, on a à peu près 9 cas par an.

Donc il se voit surtout dans les pays où vous avez les gens qui ont un phototype clair et qui vivent dans des régions ensoleillées. C'est en Australie que vous avez l'incidence la plus importante, 40 nouveaux cas par 100 000 habitants. Cette incidence varie selon les pays, la race.

Elle est rare chez les sujets asiatiques et les Africains. Elle se voit surtout chez l'adulte de 35 ans. Elle est exceptionnelle chez l'enfant.

Donc plus le sexe masculin que le sexe féminin. Et vous voyez, en Australie, on a l'incidence la plus importante. Donc c'est une tumeur qui est maligne avec gros potentiels métastatiques.

Elle est responsable de 1,2 à 1,5 par 100 000 habitants. Donc c'est une cause très importante de la mortalité dans ces pays. Vous voyez la France et l'Australie.

Et on a dit que c'est un problème de santé publique dans ces pays. Il y a beaucoup de campagnes de dépistage et de sensibilisation. Les facteurs de risque.

Les patients qui ont un risque important de développer les mélanomes. Le phototype clair. Rappelez-vous la classification de Fitzpatrick qu'on a vu lorsqu'on a parlé des cancers cutanés et pètilnaux.

Le sujet qui ne se branche jamais mais qui se brûle toujours. Le phototype 1 et 2. Ce sont des patients qui ont plusieurs tâches de rousseur. Donc des effilides.

Ce sont des patients qui font beaucoup de coups de soleil. Secondaire à l'exposition OZVV. Surtout pendant l'enfance.

Vous avez le syndrome de névus dysplasique. Ce sont des malades qui ont des dizaines ou des centaines de névus. Vous avez le névus congénital de grande taille, qu'on va voir par la suite.

Et vous avez les familles de patients ayant eu un mélanome. Donc là, ce sont des patients qu'il faut suivre de façon régulière. Voici un patient avec plusieurs névus.

Donc des dizaines de névus. Au niveau du tronc, phototype clair. Donc là, ce sont des personnes qui peuvent développer un mélanome.

Ce sont des personnes qu'il faut surveiller, qu'il faut voir tous. Tous ces névus, actuellement par le dermatoscope, et donc voir l'évolution de ces névus. Dès qu'il y a des modifications d'aspect, à ce moment-là, on fait une X-RS.

Donc là, les névus qu'il faut surveiller, et lorsque vous avez l'apparition, par exemple ici, d'une coloration hétérogène, à ce moment-là, il faut craindre la transformation. Il faut faire une X-RS chirurgicale. Voici le névus congénital géant.

Donc vous avez un névus de grande taille, plus de 20 cm. Et là, c'est des lésions qui peuvent évoluer vers des mélanomes. C'est difficile de prendre en charge ces névus.

La chirurgie, elle est très lourde. Donc on opère ces malades avec plusieurs temps opératoires. Le mélanome, sur le plan clinique, il est rare avant la puberté.

Il se voit surtout chez l'adulte, entre 40 et 50 ans. Ici, c'est surtout le corps. Dans la littérature, ce n'est pas le dos chez l'homme et la jambe chez la femme.

Mais au Maroc, la localisation la plus fréquente, c'est la plante du pied. En Europe, c'est le dos chez l'homme et la jambe chez la femme. Le dos chez l'homme, parce que lorsqu'il fait beau, les gens, en général, travaillent torse nu, font du jardinage.

Donc, ils s'exposent au soleil, font des coups de soleil. Pour la femme, la même chose. La jambe, c'est surtout à cause de l'immunogénie.

Donc, les femmes, elles ont les jambes exposées au soleil. Mais au Maroc, la localisation la plus fréquente, c'est la plante du pied. Le mélanome peut survenir de nouveau en peau saine.

C'est la règle. On va dire qu'en général, il survient en peau saine. Parfois, il survient sur un névus préexistant.

Et là, dans les différentes séries, c'est aux alentours de 5 à 10 % des névus qui peuvent se transformer en mélanome. Il y a la règle ABCDE qui permet de surveiller ces névus avant leur

transformation. On va voir les formes cliniques des mélanomes.

Donc, vous avez le mélanome à extension superficielle, les abréviations en anglais SSM, qui représente 70 à 75 % des mélanomes dans la littérature sur les séries occidentales. Il croît en deux phases. Vous avez une phase de croissance horizontale qui peut aller de 1 à 7 ans.

Et puis, vous avez l'envahissement en profondeur. Donc, une phase de croissance verticale. Au niveau du tronc, membre inférieur, le dos chez l'homme, les jambes chez la femme.

Et là, on surveille. Donc, on suspecte les mélanomes en se basant sur cette règle ABCDE. A, ça veut dire asymétrie de la lésion.

Donc, lorsque vous avez une lésion asymétrique, les bords sont irréguliers. La couleur est hétérogène. On trouve du brun, du noir, du rouge, du bleu.

Lorsque vous avez une lésion augmentée de taille, donc lorsque le diamètre est supérieur à 6 mm, une évolution récente, changement d'aspect, une lésion qui a changé d'aspect récemment, une lésion qui a saigné. Donc, tous ces éléments permettent d'orienter le diagnostic. Il faut un seul élément.

On ne va pas attendre que la lésion soit asymétrique, que les bords soient irréguliers pour suspecter le mélanome. Dès qu'il y a un changement d'un seul critère, il faut suspecter le mélanome. Actuellement, on fait un examen dermatoscopique.

Et si on suspecte le mélanome, on fait une X-rays chirurgicales. Voici donc le mélanome extension superficielle. Vous voyez la coloration.

Elle est hétérogène. Ici, vous avez du noir. Ici, du brun.

La lésion est asymétrique. Si vous prenez cet axe, ce côté-là, il est différent de ce côté. Donc, la bordure également est irrégulière.

Le diamètre. Donc, il faut mesurer cette lésion. Donc, là, la même chose.

Voici donc cette lésion. Donc, mélanome extension superficielle. Vous voyez la coloration qui est hétérogène.

Les bords qui sont irréguliers. D'accord. Le diamètre, donc supérieur à 6 mm.

Donc, la même chose ici. Donc, vous voyez cette lésion-là. Donc, au départ, vous avez cette extension horizontale et puis l'apparition de lésions ondulaires.

Donc, l'apparition de lésions ondulaires, elles témoignent de l'envahissement vertical. La même chose ici. Vous voyez, donc, les lésions.

Et puis, vous avez l'apparition d'une lésion. La même chose. Une évolution horizontale, puis l'apparition d'une lésion ondulaire témoignent de l'envahissement vertical.

La même chose. Vous voyez ici cette lésion noirâtre avec une régression de l'espèce, ici, de coloration rouge, ici, blanchâtre. Donc, des lésions hétérogènes.

Et puis, vous avez l'apparition de cette lésion ondulaire. D'accord. Témoignent de l'envahissement vertical.

Et bien sûr, l'apparition d'une lésion ondulaire, c'est un élément de mauvais pronostic. Ça veut dire que le mélanome est épais. Avec un risque important de métastase.

Donc, on a vu le mélanome d'extension superficielle. Maintenant, vous avez le mélanome ondulaire. Il représente 15 à 25 % du mélanome.

Et là, c'est une progression d'emblée verticale. C'est pas comme le SSM. C'est pas comme le mélanome d'extension superficielle où vous avez une progression au départ horizontale, puis une progression verticale.

Se voit chez les sujets âgés, entre 50 et 65 ans. Si j'ai au niveau du tronc, puis si j'ai également au niveau de la tête, au niveau du cou. C'est une lésion ondulaire ou sous forme de plaque de couleur foncée, noire ou bleue, parfois polychrome.

Il existe une forme achromique. Dans 5 % des cas. Lorsqu'on parle de mélanome ondulaire achromique, c'est pas la même chose lorsqu'on parle d'une macule achromique.

Une macule achromique, c'est une macule qui est blanchâtre. Mais une lésion ondulaire achromique, c'est une lésion qui est rouge. Donc, il y a l'aspect de la couleur normale de la peau.

C'est pas une lésion noirâtre. Une macule ondulaire achromique, ça veut dire que c'est pas noirâtre. Donc, voici les lésions ondulaires pigmentées.

Si vous voyez, c'est du noir. Ici, c'est du grain. Donc, il n'y a pas d'extension superficielle horizontale.

Là, c'est directement l'apparition d'envahissements verticaux. La même chose, vous voyez que la couleur, elle est variable. Donc, après les mélanomes à extension supérieure superficielle, les mélanomes ondulaires, vous avez les mélanomes sur mélanos de Dubreuil.

On parle également de l'antigo malin ou de mélanomes in situ. Ça représente 5 à 10 % des mélanomes. Ça donne donc des lésions des macules brunes ou polychromes, souvent de grande taille.

S'il y a surtout au niveau du visage, c'est du sujet âgé. Les femmes présentent plus cette forme

clinique que les hommes. C'est une tumeur à évolution lente.

Vous voyez l'aspect, donc une plaque polychromique avec du noir, du brun, d'accord? Au niveau du visage, là, donc, pression temporale. Ici, la même chose au niveau des joues, donc une plaque polychromique. Là, après les dizaines d'évolutions, il peut y avoir donc l'envahissement vertical profond avec l'apparition d'une ondule sur ces plaques de mélanose.

Vous avez les mélanomes acrolantigineux. Ce sont les formes les plus fréquentes chez les sujets africains, chez les Noirs. 45 % des mélanomes sont des mélanomes acrolantigineux.

C'est une forme rare chez les Blancs. Ça représente 5 à 10 %. C'est la forme la plus fréquente au Maroc avec la localisation plantaire. Donc les mélanomes acrolantigineux peuvent siéger au niveau de la pomme, des miens, des plantes, des pieds, des régions sous au péri-ingoyale et peut-être de l'angle, le mélanome ingoyale.

Donc au départ, c'est une macule pigmentée, rapidement hétérogène, parfois hyperchiracosique. Il ne faut pas attendre l'apparition d'une ondule ou d'une sélation pour poser le diagnostic. Donc c'est très important.

Dans notre contexte, il faut toujours examiner la pomme et surtout les plantes du pied. Donc les malades qu'on diagnostique au stade de juste une macule pigmentée, à ce moment-là, vous donnez plus de chance de vie à votre patient. En général, c'est des macules qu'on trouve fortuitement à l'examen clinique.

Il n'y a pas de clintes, il n'y a pas de saignements, pas de douleurs, pas d'ulcérations. C'est à ce stade qu'il faut poser le diagnostic. Donc l'examen du pied, ça fait partie de l'examen général de tout patient.

Ici, vous voyez, donc là, c'est un stade tardif. Ce malade présente ses macules depuis des années et des années avant l'apparition de cette lésion ondulaire. Donc là, ce malade, il fallait poser le diagnostic au stade juste d'une macule pigmentée.

À ce moment-là, on peut faire le dermatoscope qui permet d'orienter le diagnostic ou en cas de doute, on fait carrément une biopsie ou un exercice chirurgical. Le mélanome ingouéade, vous voyez déjà, donc vous avez l'extension de la lésion vers la pulpe des doigts et vous avez la destruction de la tablette ingouéade. Donc là, la même chose, le mélanome ingouéade, il faut suspecter le mélanome devant une macule pigmentée, une bande pigmentée qui est apparue au niveau de la tablette.

On parle de mélanomichie. Donc, lorsque vous avez une mélanomichie, il faut demander un avis spécialisé parce que ça peut être un mélanome débutant. Ici, c'est un signe très important lorsqu'on a une mélanomichie.

C'est lorsque vous avez une extension, donc lorsque vous avez une atteinte, donc une

pigmentation au niveau du repli ingouéade. Là, au niveau du repli ingouéade proximal, on parle du signe de Hutchinson. Là, une fois, il ne faut pas prendre un m-atome ingouéade pour un mélanome.

Ça, c'est un m-atome ingouéade post-traumatique. Et là, c'est un mélanome et vous voyez le signe de Hutchinson. Donc là, c'est un mélanome ingouéade.

Donc ça, c'est le dermatoscope. Le dermatoscope permet d'agrandir les lésions jusqu'à 100 fois. Donc ça permet de poser le diagnostic.

Il y a des éléments sémiologiques qui permettent de poser le mélanome. Vous voyez l'exemple en dermatoscopie. Donc il y a des critères sémiologiques.

C'est le domaine du spécialiste. On utilise également le dermatoscope pour les autres cancers, surtout également le carcinome baso-cellulaire. Donc le diagnostic différentiel des mélanomes, donc en cas de mélanome pigmenté.

Donc le diagnostic se discute avec un névus. Et là, vous avez donc l'aspect clinique, l'aspect dermatoscopique qui permet de faire la part des deux. Les caratocytoboriques pigmentés, le carcinome baso-cellulaire pigmenté, l'angiome tardif thrombosé.

Donc une lésion qui était rouge, angiomateuse, qui devient un petit peu noirâtre. Donc c'est des angiomes thrombosés. L'hystéocytophibrome pigmentée, c'est une tumeur bénigne.

Ça dépend du fibroblast. Caratose actinique. Le carcinome épidermoïde.

En cas de tumeur acromique, lorsqu'on a donc un mélanome acromique, c'est-à-dire que la lésion est là, soit une lésion nodulaire qui est rouge ou de la couleur normale de la peau. On peut discuter de l'homicome. Le carcinome baso-cellulaire nodulaire.

Maladie de Kaposi. Hystéocytophibrome. Carcinome épidermoïde.

Donc la conduite à tenir en cas de suspicion de mélanome. Si vous êtes devant une lésion de petite taille, la taille, c'est en fonction de la topographie. Par exemple, si vous avez une lésion même de 3 cm au niveau du dos, on peut faire un exercice total et un examen histologique rapide.

Mais si vous avez une lésion de 3 cm, par exemple, au niveau du visage, à ce moment-là, on ne va pas faire un exercice total, mais on va faire une biopsie partielle avec une histologie rapide et puis un exercice complet lorsque le diagnostic de mélanome est confirmé. Lorsqu'on fait une biopsie, l'anatome pathologiste va vous poser le diagnostic d'une prolifération de mélanocytes timoraux regroupés en tecs, donc irréguliers, ou en amas. Parfois, lorsque les mélanocytes sont atypiques, on peut s'aider de l'immunohistochimie pronostique.

Vous voyez donc les proliférations mélanocytaires. Donc, à côté de cette prolifération mélanocytaire, l'anatome pathologiste doit identifier des éléments distopronostiques. Il y a le niveau de Clark, c'est le niveau d'envahissement timoral, et vous avez l'indice de Brest-Lyon.

Donc, le niveau de Clark, lorsque la tumeur, le mélanome, est juste au niveau de l'épiderme, donc il n'y a pas d'envahissement du derme, il y a le respect de la membrane basale, donc c'est un niveau 1. Et là, c'est un mélanome in situ, le pronostic est bon. Le niveau 2, c'est lorsque vous avez un envahissement du derme superficiel, derme papillaire. Le niveau 3, c'est la jonction derme papillaire-derme vésiculaire.

Le niveau 4, c'est le derme vésiculaire. Le niveau 5, c'est l'envahissement du lipoderme. Vous avez l'indice de Brest-Lyon.

Donc, l'indice de Brest-Lyon, il mesure l'épaisseur de la tumeur. Donc, c'est l'épaisseur de la tumeur mesurée par un opulaire micrométrique. Donc, les mélanomes sont fins lorsque l'épaisseur de Brest-Lyon, ou l'indice de Brest-Lyon, il est inférieur à 0,75 mm.

Le mélanome épais, c'est lorsque vous avez entre 1,5 et 4 mm. Entre 0,75 et 1, c'est un mélanome qui est moyen. Et le mélanome très épais, c'est lorsqu'il dépasse 4 mm.

C'est un élément de histopronostic important, donc l'indice de Brest-Lyon. Voici la corrélation entre l'indice de Brest-Lyon et le niveau de Clark. Donc, le mélanome est situé.

C'est le stade niveau 1. Niveau 2, c'est l'atteinte du derme superficielle, papillifère. Le derme niveau 3, c'est l'atteinte de la jonction, derme papillaire, derme réticulaire. Le niveau 4, c'est le derme réticulaire.

Le niveau 5, c'est l'hypoderme. Vous voyez l'indice de Brest-Lyon. Donc, il mesure l'épaisseur de la tumeur, c'est-à-dire la cellule tumorale la plus haute jusqu'à la cellule tumorale la plus profonde.

Et plus l'indice est élevé, plus le pronostic est mauvais. Le bilan d'extension en cas de mélanome, le mélanome est une tumeur hautement métastatique. Donc, en dehors des mélanomes in situ lorsqu'il n'y a pas d'envahissement d'une membrane basale, à ce moment-là, on ne fait pas de bilan d'extension.

Dans les autres cas, il faut faire un bilan. Pas du tout avec psychographie abdominale, TDM, corps entier. Ou mieux, le PET scan.

Donc, la classification la plus simple des mélanomes, c'est la classification. Donc, vous avez un tumeur primitif localisé. Il n'y a pas de métastase ganglionnaire, pas de métastase à distance et pas de récurrence locale.

Stade 2, c'est lorsque vous avez une récurrence locale du mélanome ou atteinte ganglionnaire

régionale. Stade 3, c'est lorsque vous avez des métastases à distance. Des métastases viscéres.

Il y a cette classification A, G, C, C. Donc, la 7e édition, c'est une classification TNM. Donc, vous avez la tumeur. On prend en considération la tumeur primitif.

Donc, l'épaisseur de Breslau, c'est très important. Donc, lorsque vous avez un indice de Breslau inférieur à 1 mm, vous êtes dans T1. Lorsqu'il est entre 1,01 et 2 mm, vous êtes dans T2.

2 mm et 4, T3 et T4. D'accord? Et toujours. Donc, on voit s'il y a une ulcération avec ou sans ulcération.

Et puis, vous avez l'existence d'adénopathie et l'existence de métastases. Donc, c'est une classification TNM. Et puis, en fonction de ces tumeurs, la taille des tumeurs, se basant sur l'indice de Breslau, l'existence de métastases ganglionnaires et de métastases viscérales, on fait cette stadification.

Donc, du stade 0, c'est in situ. Du 1A jusqu'à 2C, c'est des tumeurs sans métastases ganglionnaires, sans métastases viscérales. Et lorsque vous avez des métastases ganglionnaires, c'est le stade 3. Et puis, vous avez stade 4, c'est en cas de métastases.

Le traitement idéal, le traitement de référence, c'est la chirurgie. Avec des marges carcinologiques de 1 à 3 cm. Ça ne sert à rien de dépasser 3 cm.

Donc, lorsque vous avez un mélanome in situ, la marge d'exérés doit être de 0,5 cm. Donc, là, c'est très important. On pose le diagnostic à ce stade.

Lorsque vous avez l'indice de Brest-Léo entre 0,1 et 1 mm, il faut faire une marge de sécurité de 1 cm. Lorsqu'il est le mélanome et l'indice de Brest-Léo entre 1,1 et 2, là, on fait une marge de 1 à 2 cm. Lorsque le mélanome est épais, très épais, sur plus de 2 mm, il faut faire une marge de 2 cm, parfois plus, jusqu'à 3 cm.

Curage ganglionnaire, c'est une métastase régionale. L'interférent peut être proposé en cas de traitement adjuvant, lorsqu'on est devant des métastases ganglionnaires. Chimiothérapie, c'est une métastase, mais actuellement, on ne donne plus la chimiothérapie dans les pays développés.

On donne plus l'immunothérapie en cas de mélanome métastatique. Ce sont des inhibiteurs de BRAF et inhibiteurs de MEK. On utilise les anticorps monoclonaux anti-CTL4, donc CTLA4 ou anti-PDA.

Anti-PDA, il est actuellement commercialisé au Maroc. Donc, la survie en 5 ans, elle est de 96 % lorsqu'on est devant des mélanomes fins, et cette survie, elle diminue en fonction de l'épaisseur de la tumeur. Donc, le mélanome est une tumeur hautement métastatique.

Il faut insister sur la prévention primaire en sensibilisant les patients sur le danger de l'exposition solaire. La prévention primaire, également, consiste à suivre les patients à risque. D'accord? Conseiller, donc, la photoprotection.

Dépistage précoce, c'est très important. Examinez la plante des pieds de vos patients, et lorsqu'on est devant des lésions suspects, à ce moment-là, on fait un exercice chirurgical avec études histologiques.